

MINISTERIO DE SALUD DEL PERÚ · DIRESA LIMA PROVINCIAS · RIS
HUARAL

ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD

ASIS 2026

CENTRO DE SALUD CLAS AGREGADO LA QUERENCIA

Distrito de Huaral · Provincia de Huaral · Región Lima Provincias

PERIODO DE ANÁLISIS	2025 (línea base) · Horizonte del Plan 2025–2028
FECHA DE ELABORACIÓN	JUNIO 2026
EQUIPO TÉCNICO	CLAS Agregado La Querencia – Área de Administración – Servicios Asistenciales.

DIRESA LIMA PROVINCIAS · RIS DE SALUD HUARAL

ÍNDICE

Los números de página se generan automáticamente en Word: clic derecho sobre este índice → "Actualizar campos" (o seleccione todo el documento con Ctrl+A y presione F9).

1. RESUMEN EJECUTIVO	4
1.1 Mapa de Ámbito – Sectores del CLAS La Querencia	4
1.2 Principales Hallazgos Epidemiológicos (2024-2025)	5
2. CONTEXTO GENERAL DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	5
2.1 Ubicación Geográfica y Accesibilidad	5
2.2 Saneamiento y Vulnerabilidad Territorial por Sector	5
2.3 Pirámide Poblacional – Distrito de Huaral 2025.....	5
2.4 Pirámide Poblacional 2026 – C.S. CLAS Agregado La Querencia	7
3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y PERFIL EPIDEMIOLÓGICO	8
3.1 Principales Causas de Morbilidad – Distrito de Huaral 2024.....	8
3.2 Principales Causas de Morbilidad – C.S. La Querencia 2024.....	8
3.3 Principales Causas de Mortalidad – Distrito de Huaral 2024	9
3.4 Tendencia Mensual de IRA y EDA – 2025.....	9
3.5 Morbilidad en Adolescentes (12-17 años) – 2025	10
ENFERMEDADES CRÓNICAS, NUTRICIÓN Y ANEMIA	11
3.6 Estado Nutricional (IMC) en Adultos – 2025	11
3.7 Prevalencia de Anemia por Grupo Etario – 2025.....	11
3.8 Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) – 2025	12
SALUD MENTAL, TUBERCULOSIS Y VACUNACIÓN	13
3.9 Diagnósticos de Salud Mental – 2025	13
3.10 Tuberculosis – Casos Identificados 2025	13
3.11 Cobertura de Vacunación – 2025	14
4. ANÁLISIS DE GESTIÓN Y CALIDAD	15
4.1 Producción de Atenciones por Profesión – 2025	15
4.2 Dimensiones de Calidad – Radar de Línea Base 2025.....	15
4.3 Financiamiento por Tipo de Asegurado – 2025	16
5. CAPACIDAD INSTALADA: RECURSOS HUMANOS, INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN INSTITUCIONAL	16
5.1 Red de Establecimientos y Categorización.....	16
5.2 Dotación de Recursos Humanos y Brecha 2026	17
5.3 Infraestructura Física y Proyecto de Recategorización a I-4.....	18
5.4 Situación Institucional y Financiera.....	19
6. BRECHAS ESTRATÉGICAS Y PLAN DE ACCIÓN 2025-2028	20
6.1 Brechas Estratégicas Priorizadas	20
7. Recomendaciones Estratégicas 2025-2028	21
8. Conclusiones del ASIS	21

8.1 Perfil epidemiológico: una doble carga que se agrava en cascada.....	21
8.2 Gestión y calidad: la oferta no está dimensionada para la demanda que documenta el perfil epidemiológico.....	22
8.3 Capacidad institucional: la brecha de recursos humanos es la causa raíz común	22
8.4 Síntesis: diez brechas, una hoja de ruta hacia 2028.....	22

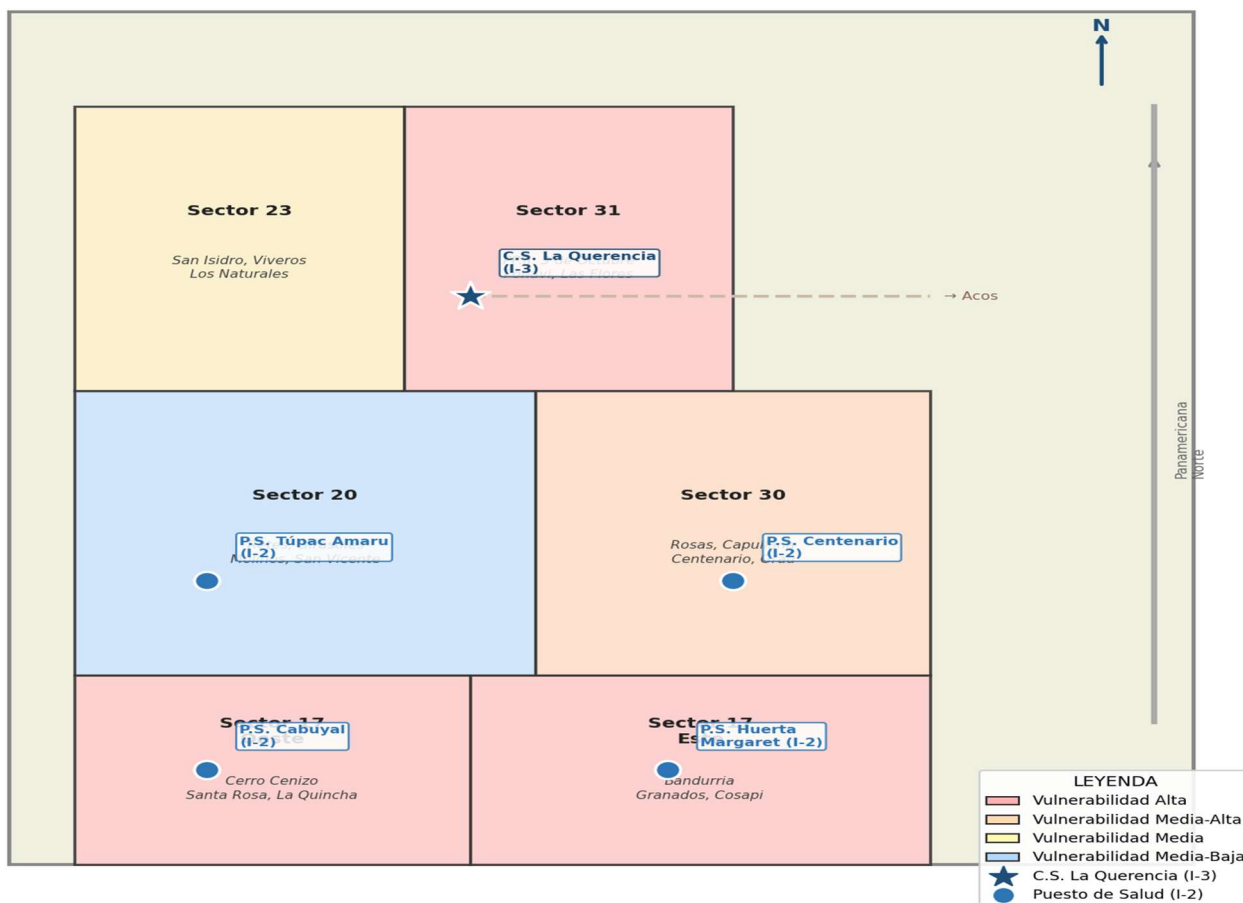
1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente Análisis Situacional de Salud (ASIS) del Centro de Salud CLAS Agregado La Querencia, correspondiente al distrito de Huaral, Región Lima Provincias, constituye el insumo técnico fundamental para la formulación del Plan Estratégico Institucional 2025-2028. Se ha elaborado con un enfoque participativo, territorial y por etapas de vida, alineado con los objetivos nacionales del MINSA y la Dirección Regional de Salud Lima Provincias.

1.1 Mapa de Ámbito – Sectores del CLAS La Querencia

El CLAS Agregado La Querencia cubre 6 sectores geográficos del distrito de Huaral, con una población estimada de 29,000 habitantes. El mapa referencial a continuación muestra la distribución de establecimientos de salud y los niveles de vulnerabilidad por sector.

MAPA REFERENCIAL - ÁMBITO DE INFLUENCIA
CLAS Agregado La Querencia · Distrito de Huaral, Lima Provincias



Nota: Mapa esquemático de referencia. Sectores representados de forma proporcional. Escala aproximada.

Figura 1. Mapa referencial de sectores – CLAS Agregado La Querencia, Distrito de Huaral 2025

⚠️ ALERTA EPIDEMIOLÓGICA: Las IRA (2,923 casos), el exceso de peso (61.3% de adultos) y la baja cobertura de salud mental (12% de tamizaje en adolescentes) constituyen las brechas prioritarias del CLAS.

CLAS AGREGADO LA QUERENCIA

Av. Victoria Mz: A Lote : 4 Esperanza Baja - Huaral E-mail: claslaquerencia@gmail.com

1.2 Principales Hallazgos Epidemiológicos (2024-2025)

Área	Hallazgo Clave	Magnitud
Morbilidad Distrital	IRA (5,432), EDA (4,210), HTA (3,890), DM (3,455)	Alta
Morbilidad C.S. Querencia	IRA (2,923), Exceso de peso (1,056), SM (657)	Alta
Mortalidad Distrital	Enf. cerebrovasculares (198), Neoplasias (182), DM (165)	Alta
Adolescentes (12-17a)	Sobrepeso/obesidad 44%, VPH 38%, Salud mental 12%	Crítica
Calidad Asistencial	Espera 75 min, 0% HCE, 20% EESS agua segura	Crítica
Tuberculosis	29 casos, tasa 26.4 x 100,000 – supera umbral	Alta

2. CONTEXTO GENERAL DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

2.1 Ubicación Geográfica y Accesibilidad

El distrito de Huaral se ubica en la provincia de Huaral, Región Lima Provincias, a 87 km al norte de Lima. El CLAS Agregado La Querencia cubre los sectores 23, 31, 20, 17 Oeste, 17 Este y 30, en zona urbano-periurbana del distrito.

2.2 Saneamiento y Vulnerabilidad Territorial por Sector

El acceso a agua, desagüe y electricidad es heterogéneo entre los seis sectores del ámbito, con los niveles de riesgo más altos concentrados en los sectores periféricos sin cobertura de saneamiento básico:

Sector	Principales Zonas	Agua	Desagüe	Electricidad	Riesgo
23	San Isidro, Viveros, Los Naturales	Parcial	Parcial	Sí	Medio
31	PP.JJ. 3 de Octubre, Fonavi, Las Flores	No	No	Si	Alto
20	Retes, Girasoles, Molinos, San Vicente	Sí	Sí	Sí	Bajo
17 O	Cerro Cenizo, Santa Rosa, La Quincha	No (zonas altas)	No	Parcial	Alto
17 E	Bandurria, Granados, Cruce Huando	No	No	Parcial	Alto
30	Rosas, Capullana, Grau, Circunvalación N	Parcial	No	Parcial	Medio-Alto

2.3 Pirámide Poblacional – Distrito de Huaral 2025

La población estimada es de 110,000 habitantes, con una distribución etaria predominantemente joven. Los adolescentes (12-17 años) representan ~9.5% (~10,450 personas), siendo población priorizada en este ASIS.

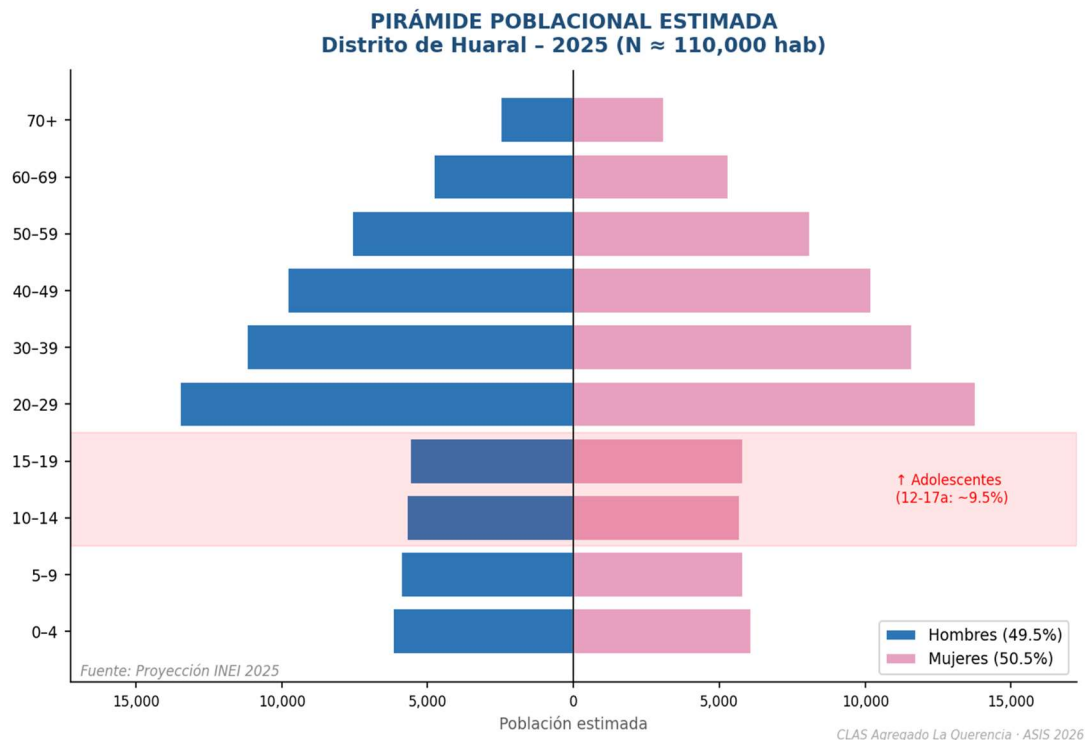


Figura 2. Pirámide poblacional estimada – Distrito de Huaral 2025 (Fuente: Proyección INEI)

La estructura poblacional evidencia una pirámide con base relativamente amplia en edad activa (20-59 años), lo que genera alta demanda de servicios preventivo-promocionales y control de enfermedades crónicas. El crecimiento del adulto mayor (60+, ~11,000 hab) exige preparar servicios de atención continuada y gerontológica.

2.4 Pirámide Poblacional 2026 – C.S. CLAS Agregado La Querencia

A diferencia de la proyección distrital de la Figura 2, esta pirámide utiliza el padrón poblacional propio del CLAS (suma de los sectores 17, 20, 23, 30 y 31), con una población de 22,716 habitantes al 2026 (47.7% hombres, 52.3% mujeres). Es la base demográfica más precisa disponible para la programación de servicios del establecimiento.

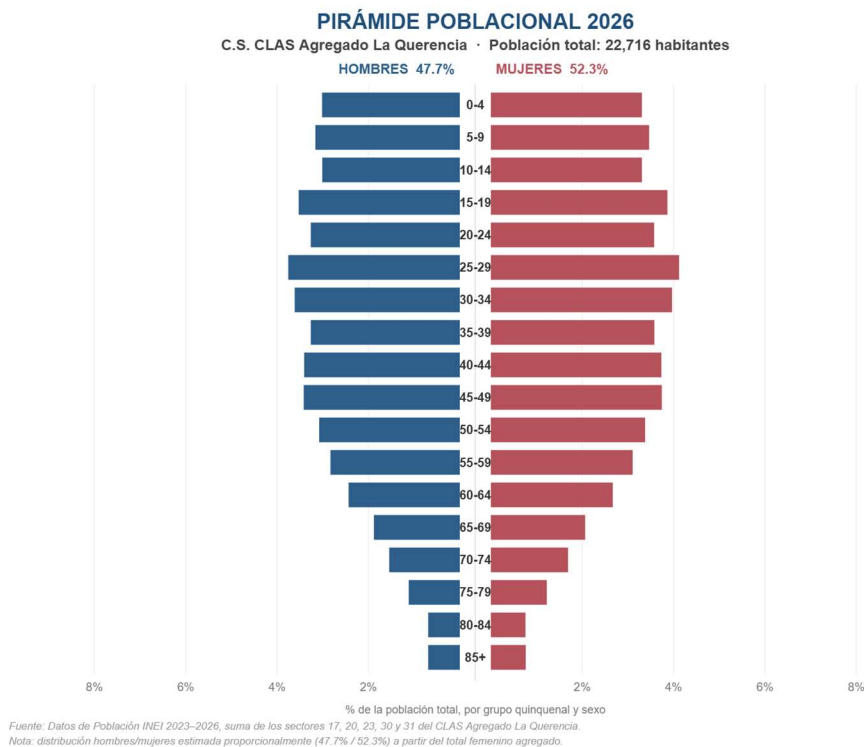


Figura 3. Pirámide poblacional 2026, C.S. CLAS Agregado La Querencia (Fuente: Datos de Población INEI 2023–2026, sectores 17, 20, 23, 30 y 31)

La estructura muestra un ensanchamiento en el grupo de 25-29 años (7.9% del total, el más numeroso), compatible con atracción migratoria laboral hacia el ámbito del CLAS. La base infantil (0-14 años) agrupa a 4,376 personas (19.3%) frente a 3,981 adultos mayores de 60+ (17.5%): un **índice de envejecimiento de 91.0**, que evidencia una transición demográfica acelerada. La razón de dependencia total es de 58.2 personas dependientes por cada 100 en edad activa (15-59 años), lo que sostiene la necesidad de fortalecer simultáneamente los programas materno-infantiles y la atención geriátrica.

3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y PERFIL EPIDEMIOLÓGICO

3.1 Principales Causas de Morbilidad – Distrito de Huaral 2024

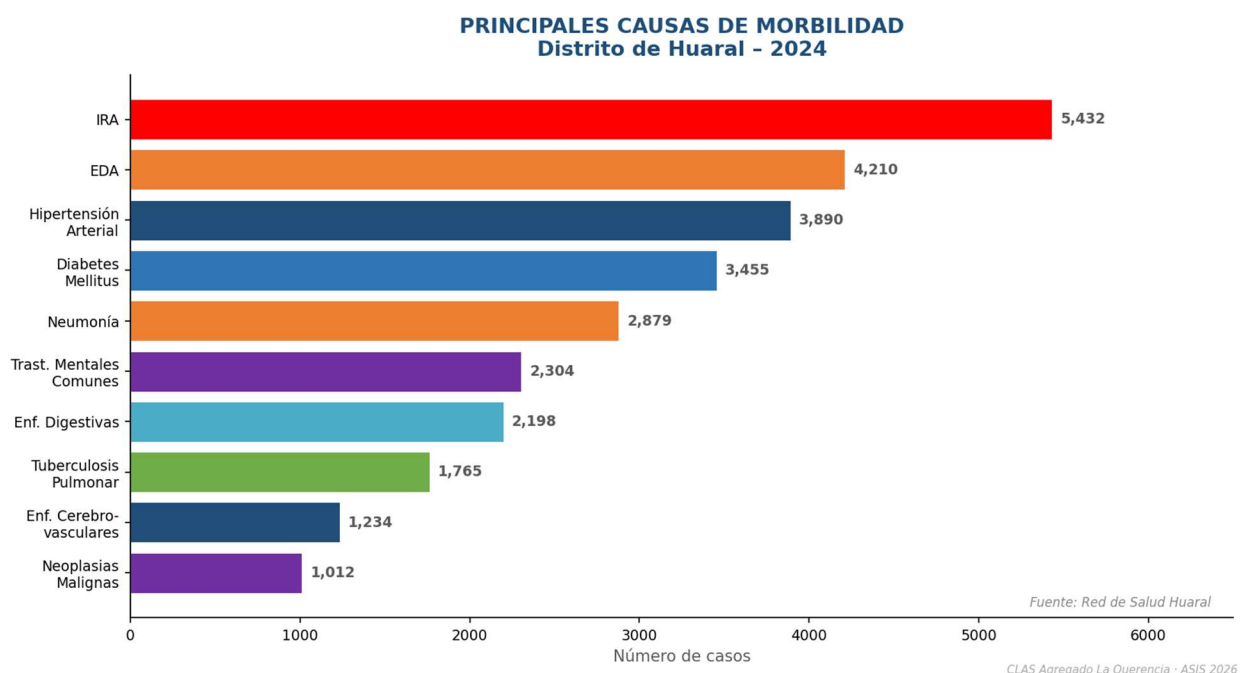


Figura 4. Principales causas de morbilidad, Distrito de Huaral 2024 (Fuente: Red de Salud Huaral)

Las IRA continúan liderando la morbilidad distrital con 5,432 casos, seguidas de EDA (4,210), hipertensión arterial (3,890) y diabetes mellitus (3,455). El patrón refleja la doble carga epidemiológica típica de distritos en transición: enfermedades transmisibles aún prevalentes junto con un incremento acelerado de enfermedades crónicas no transmisibles.

3.2 Principales Causas de Morbilidad – C.S. La Querencia 2024

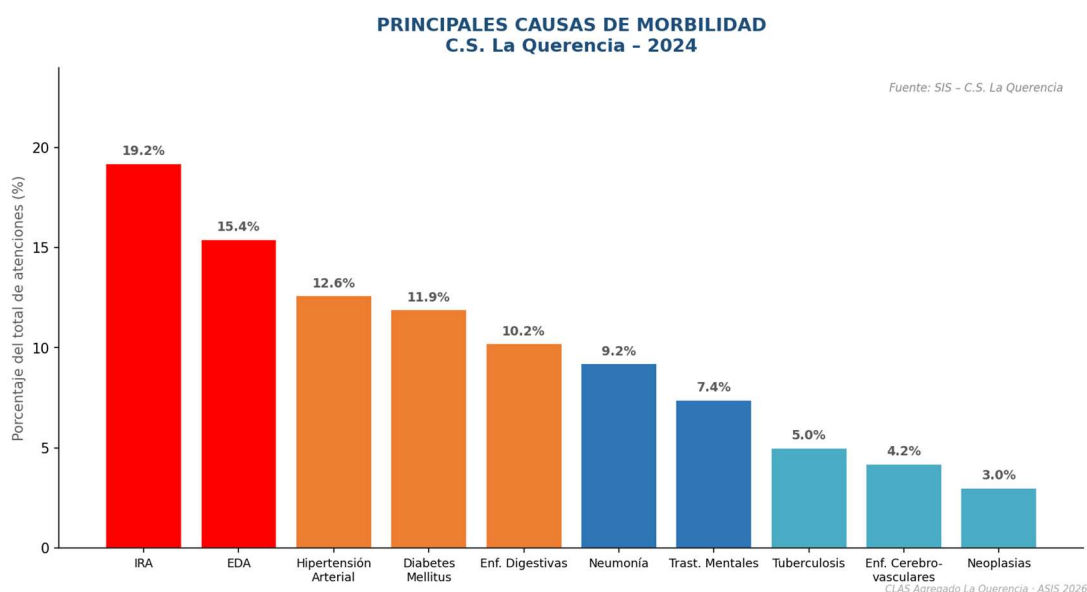


Figura 5. Principales causas de morbilidad, C.S. La Querencia 2024 (Fuente: SIS – C.S. La Querencia)

3.3 Principales Causas de Mortalidad – Distrito de Huaral 2024

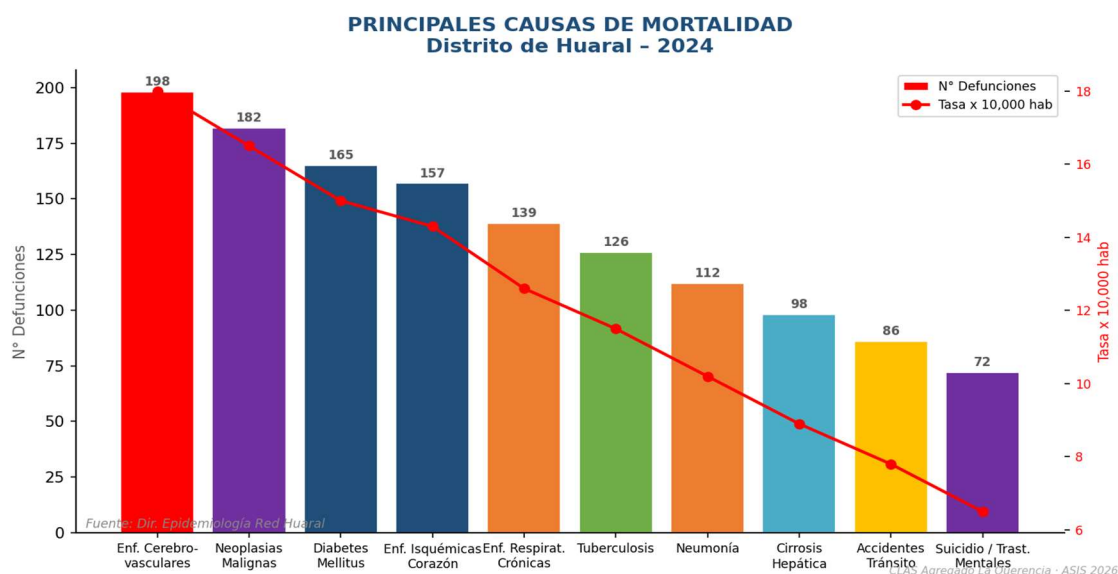


Figura 6. Causas de mortalidad con tasa x 10,000 hab, Distrito de Huaral 2024 (Fuente: Dir. Epidemiología Red Huaral)

⚠ Las enfermedades cerebrovasculares (198 muertes), neoplasias (182) y diabetes (165) lideran la mortalidad. El suicidio y trastornos mentales (72 defunciones) alertan sobre la necesidad urgente de ampliar la atención de salud mental.

3.4 Tendencia Mensual de IRA y EDA – 2025

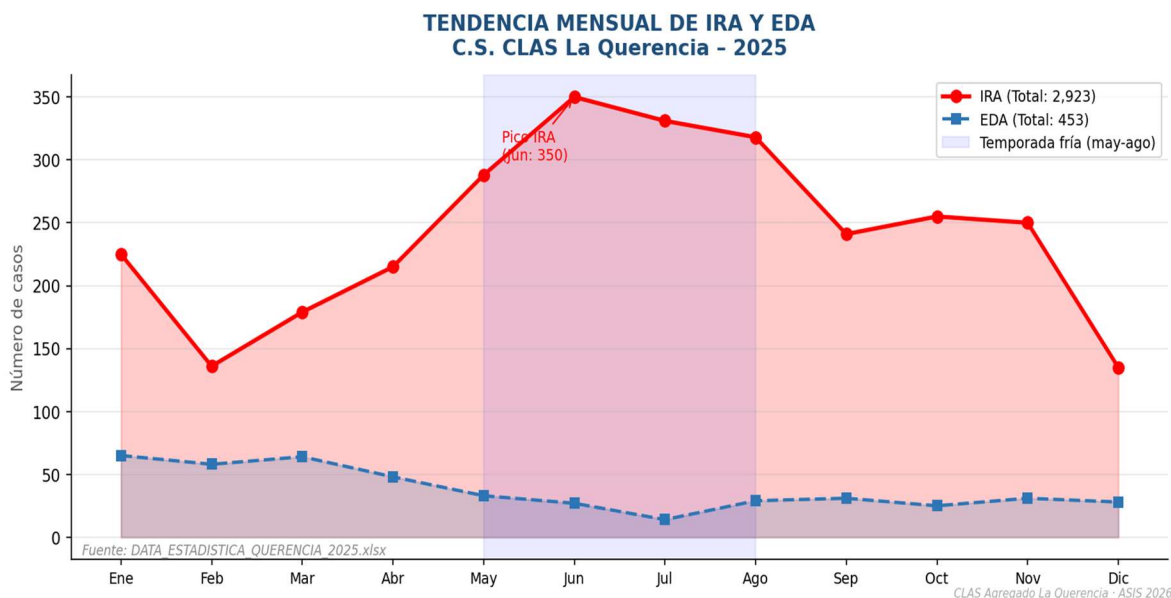


Figura 7. Tendencia mensual de IRA y EDA, C.S. CLAS La Querencia 2025 (Fuente: DATA_ESTADISTICA_QUERENCIA_2025.xlsx)

Las IRA muestran un pico estacional en junio (350 casos), coherente con la temporada fría del litoral central (mayo-agosto). Las EDA presentan comportamiento inverso: mayor frecuencia en verano (enero-marzo) y descenso marcado en invierno (julio: 14 casos). Esta estacionalidad debe orientar la programación de campañas de vacunación antigripal y la vigilancia de calidad del agua.

3.5 Morbilidad en Adolescentes (12-17 años) – 2025

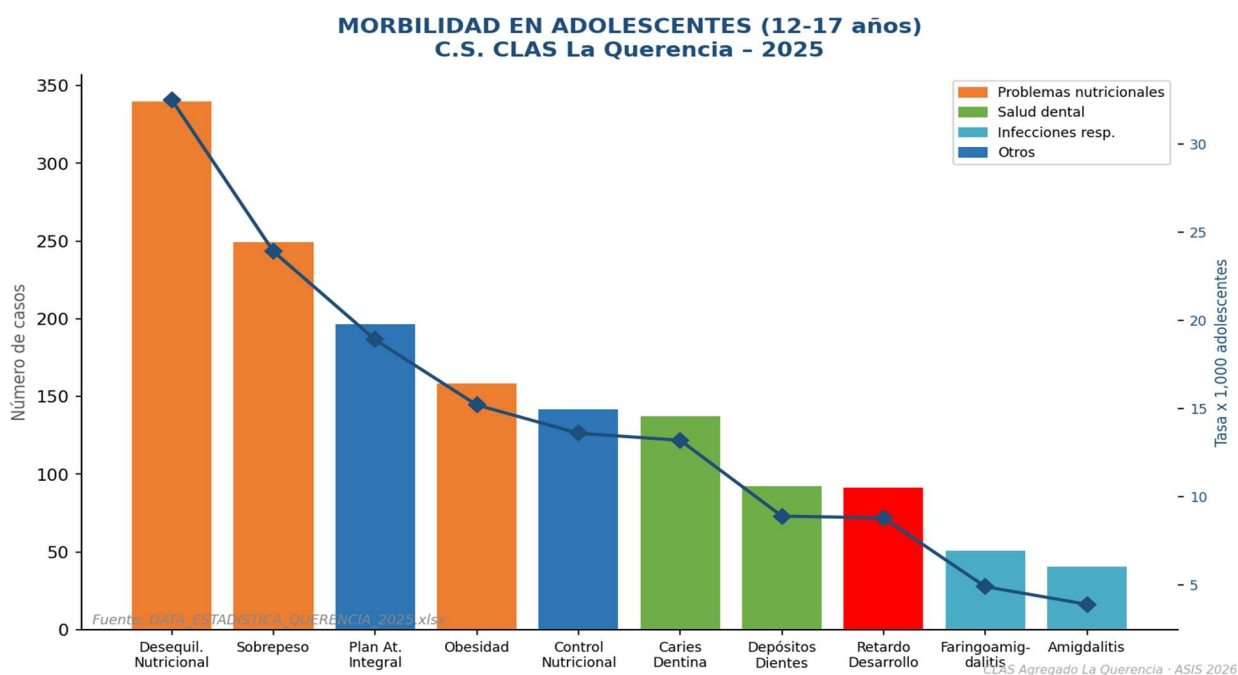


Figura 8. Morbilidad en adolescentes (12-17 años), C.S. CLAS La Querencia 2025

Los problemas nutricionales dominan la morbilidad adolescente: desequilibrio nutricional (32.5 x 1,000), sobrepeso (23.9 x 1,000) y obesidad (15.2 x 1,000) suman más del 44% de las atenciones del grupo etario. Este perfil configura una alerta epidemiológica urgente para la prevención de ECNT en edad adulta.

CIE-10	Diagnóstico	Casos	% Grupo	Tasa x 1,000
E631	Desequilibrio constituyentes dieta	340	20.3%	32.5
E660	Sobrepeso	250	14.9%	23.9
C8002	Plan de atención integral	197	11.7%	18.9
E669	Obesidad	159	9.5%	15.2
U8170	Control y evaluación nutricional	142	8.5%	13.6
K021	Caries de la dentina	138	8.2%	13.2
E45X	Retardo del desarrollo (desnutrición)	92	5.5%	8.8
J068	Faringo amigdalitis aguda	51	3.0%	4.9

ENFERMEDADES CRÓNICAS, NUTRICIÓN Y ANEMIA

3.6 Estado Nutricional (IMC) en Adultos – 2025

ESTADO NUTRICIONAL (IMC) EN ADULTOS
C.S. CLAS La Querencia - 2025

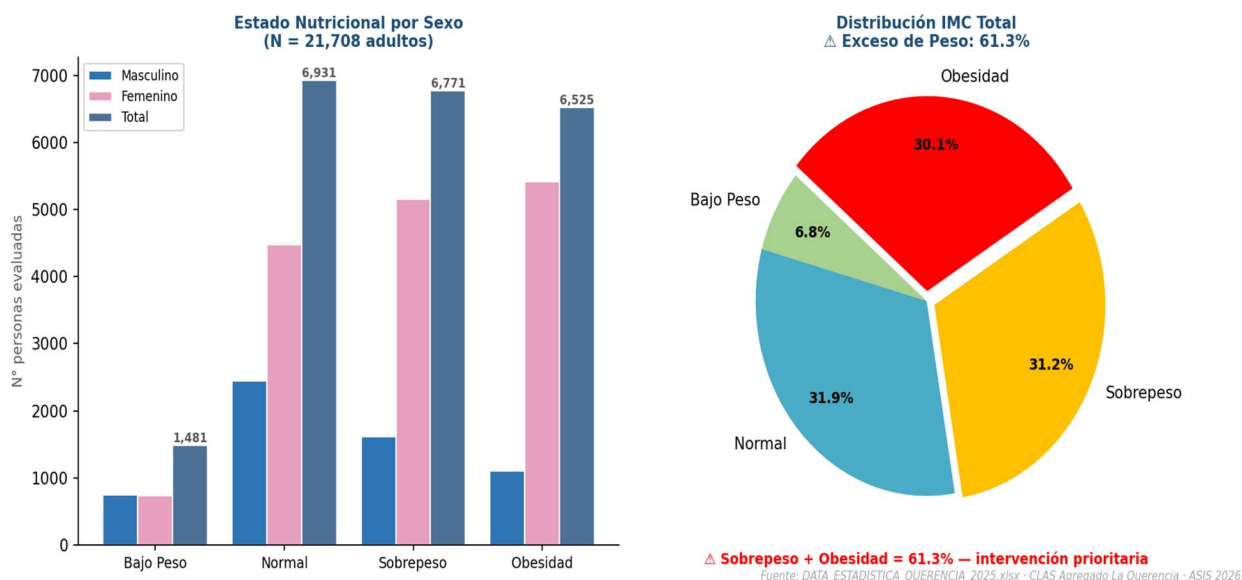


Figura 9. Estado nutricional por IMC y sexo, C.S. CLAS La Querencia 2025 (N = 21,708 adultos)

⚠️ ALERTA CRÍTICA: El 61.3% de adultos presenta exceso de peso (sobrepeso 31.2% + obesidad 30.1%). La obesidad en mujeres (34.3%) supera en 15.6 pp a la de hombres (18.7%). Esta situación eleva el riesgo de HTA, DM tipo 2, dislipidemias y enfermedades cardiovasculares.

3.7 Prevalencia de Anemia por Grupo Etario – 2025

PREVALENCIA DE ANEMIA POR GRUPO ETARIO
C.S. CLAS La Querencia - 2025 (N = 3,017 evaluados)

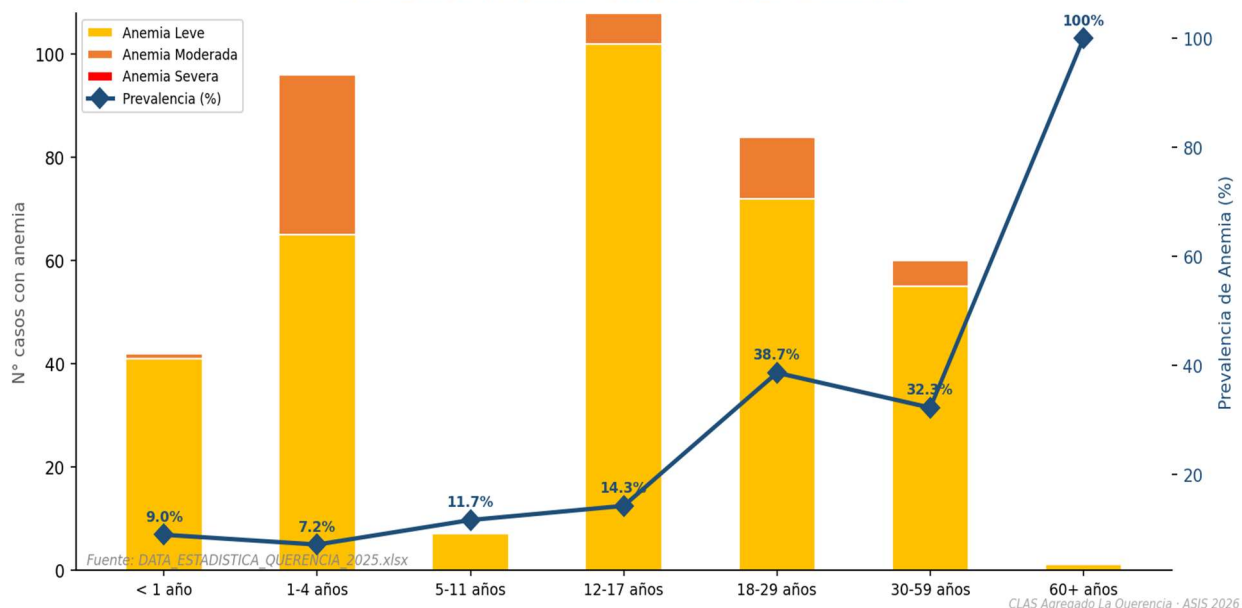


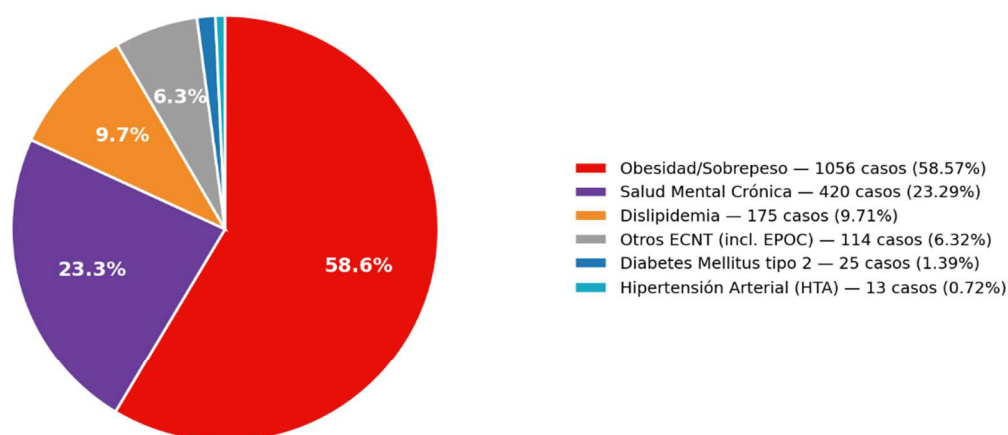
Figura 10. Prevalencia de anemia por grupo etario, C.S. CLAS La Querencia 2025 (N = 3,017 evaluados)

La anemia en adultos jóvenes (18-29 años: 38.7%) y adultos (30-59 años: 32.3%) supera ampliamente los valores en menores de 5 años (7.2-9.0%), reflejando principalmente anemia en mujeres en edad fértil. En menores de 1 año la prevalencia de 9.0% exige monitoreo por su impacto en el neurodesarrollo.

Grupo Etario	Evaluados	Con Anemia	Prevalencia %	Hb Prom.
< 1 año	469	42	9.0%	11.7
1-4 años	1,331	96	7.2%	11.7
5-11 años	60	7	11.7%	12.5
12-17 años	753	108	14.3%	12.8
18-29 años	217	84	38.7%	12.1
30-59 años	186	60	32.3%	12.3
TOTAL	3,017	398	13.2%	12.0

3.8 Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) – 2025

ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES (ECNT) Distribución por Grupo - C.S. CLAS La Querencia 2025 (Total: 1,803 casos)



△ Nota: HTA y DM tipo 2 están subregistradas en el sistema HIS.
Prevalencia real estimada: HTA ~18% y DM ~12% de la población adulta,
lo que evidencia la necesidad urgente de campañas activas de tamizaje.

Fuente: DATA_ESTADISTICA_QUERENCIA_2025.xlsx · CLAS Agregado La Querencia · ASIS 2026

Figura 11. Distribución de ECNT por grupo diagnóstico, C.S. CLAS La Querencia 2025 (N = 1,803 casos)

El sobrepeso y la obesidad concentran el 58.5% de los casos de ECNT (1,056 casos). La HTA (13 casos) y DM tipo 2 (25 casos) aparecen subregistradas: la prevalencia real estimada es HTA ~18% y DM ~12% de la población adulta, evidenciando la necesidad urgente de campañas activas de tamizaje.

SALUD MENTAL, TUBERCULOSIS Y VACUNACIÓN

3.9 Diagnósticos de Salud Mental – 2025

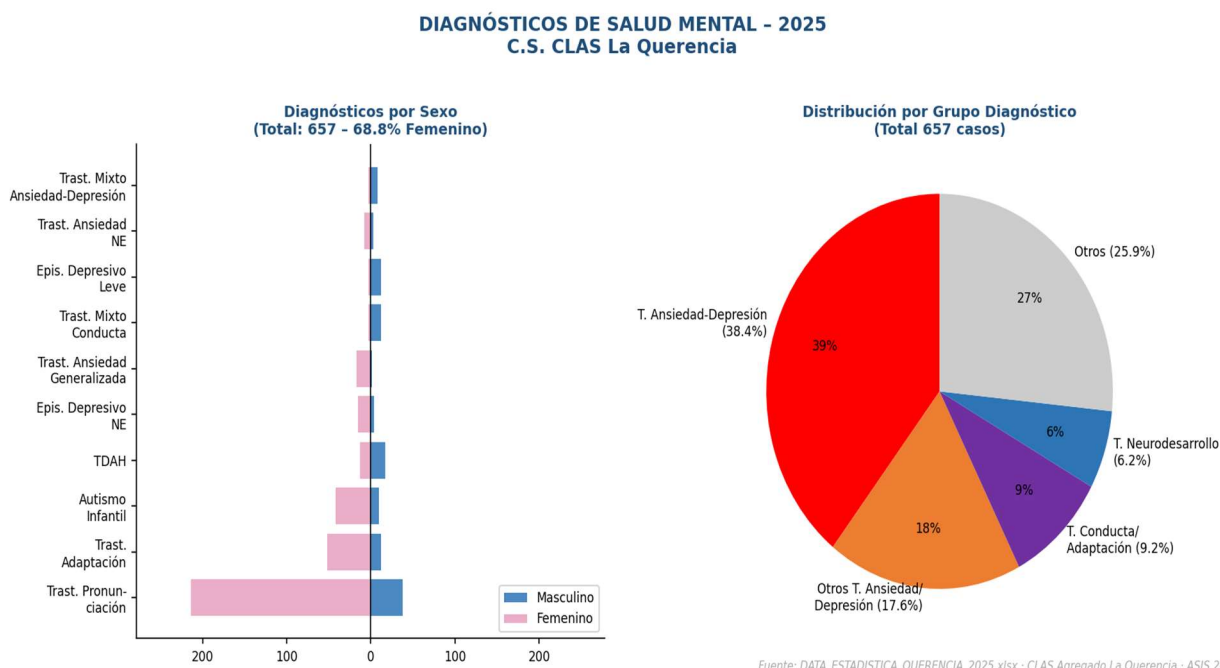


Figura 12. Diagnósticos de salud mental por sexo y grupo, C.S. CLAS La Querencia 2025 (N = 657 casos)

Se identificaron 657 diagnósticos de salud mental, con predominio del trastorno mixto ansiedad-depresión (38.4%, tasa 22.9 x 10,000 hab). El 68.8% de los casos son femeninos, lo que puede reflejar mayor disposición de las mujeres a consultar, pero también mayor exposición a violencia de género. Con solo 2 psicólogos para 110,000 hab, el subregistro estimado supera el 60%.

⚠ Con 2 psicólogos para 110,000 habitantes, el ratio es 1:55,000 — muy por debajo del estándar OMS (1:10,000). Se estiman más de 1,600 casos reales de trastornos de salud mental en la población.

3.10 Tuberculosis – Casos Identificados 2025

CIE-10	Diagnóstico	Total	Masc.	Fem.	Tasa x 100,000
A150	TBC pulmonar BK(+)	14	6	8	12.7
A160	TBC pulmonar BK(-) cultivo(-)	4	4	0	3.6
A156	Pleuresía tuberculosa confirmada	3	3	0	2.7
A153	TBC pulmonar confirmada	3	2	1	2.7
Otros	Otras formas de TB	5	2	3	4.5
TOTAL	TUBERCULOSIS TOTAL	29	17	12	26.4

La tasa de 26.4 x 100,000 supera el umbral de control. Los picos en mayo-junio (6 casos/mes) pueden estar relacionados con mayor búsqueda activa de casos. Se requiere intensificar el DOTS comunitario y el seguimiento de contactos.

3.11 Cobertura de Vacunación – 2025

COBERTURA DE VACUNACIÓN - 2025 C.S. CLAS La Querencia

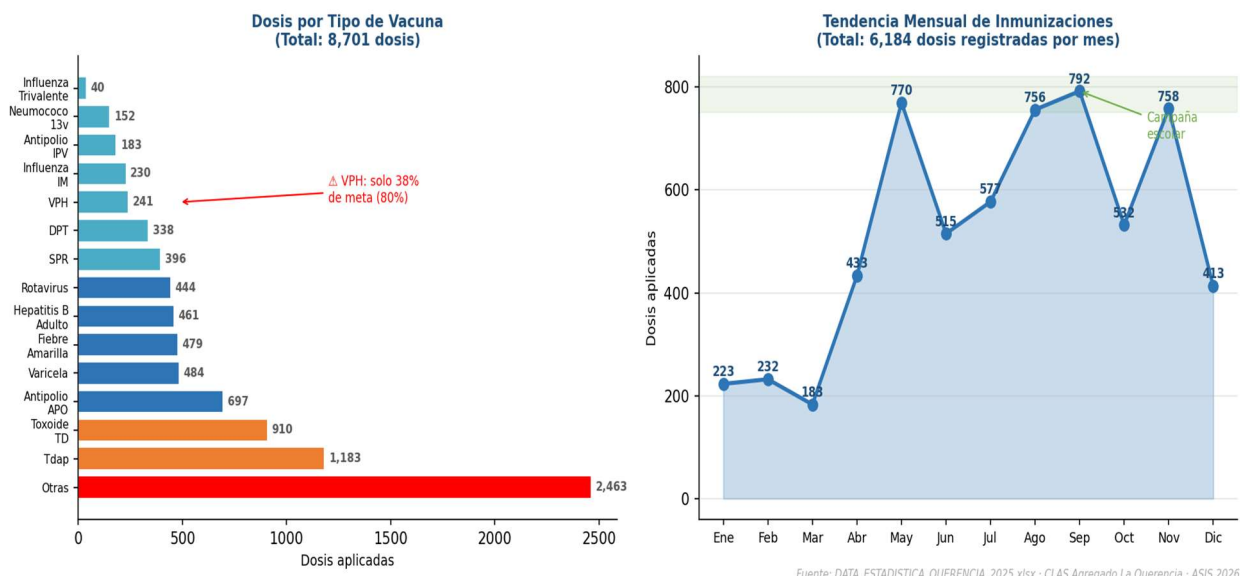


Figura 13. Dosis aplicadas y tendencia mensual de vacunación, C.S. CLAS La Querencia 2025 (Total: 8,701 dosis)

La influenza trivalente lidera con 2,463 dosis (28.3%). La vacuna VPH registra solo 484 dosis (38% de cobertura vs meta 80%), brecha crítica en niñas de 12-14 años. Los picos de mayo y septiembre-octubre coinciden con las campañas escolares. Marzo (183 dosis) es el mes de menor actividad inmunizadora.

4. ANÁLISIS DE GESTIÓN Y CALIDAD

4.1 Producción de Atenciones por Profesión – 2025

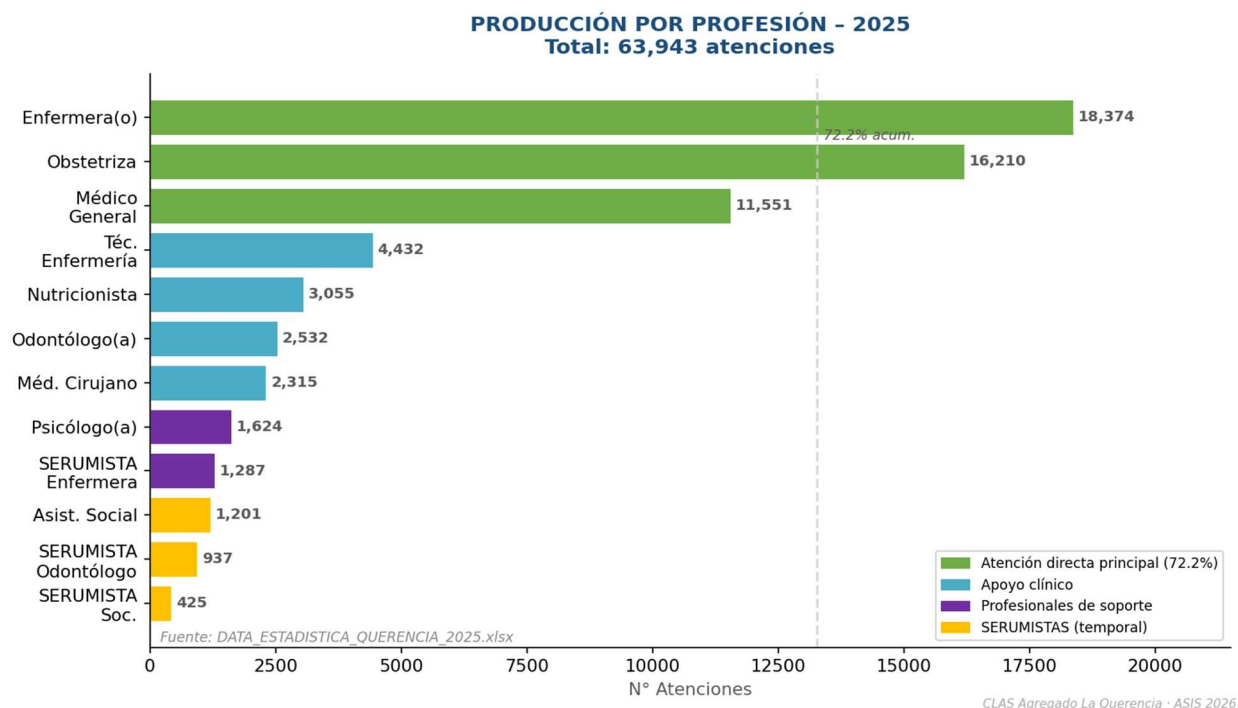


Figura 14. Producción de atenciones por profesión, C.S. CLAS La Querencia 2025 (Total: 63,943 atenciones)

Enfermería (18,374; 28.7%), obstetricia (16,210; 25.4%) y medicina general (11,551; 18.1%) concentran el 72.2% de la producción. Psicología produce solo 1,624 atenciones (2.5%), reflejando la insuficiencia del equipo de salud mental para una población de 110,000 habitantes.

4.2 Dimensiones de Calidad – Radar de Línea Base 2025

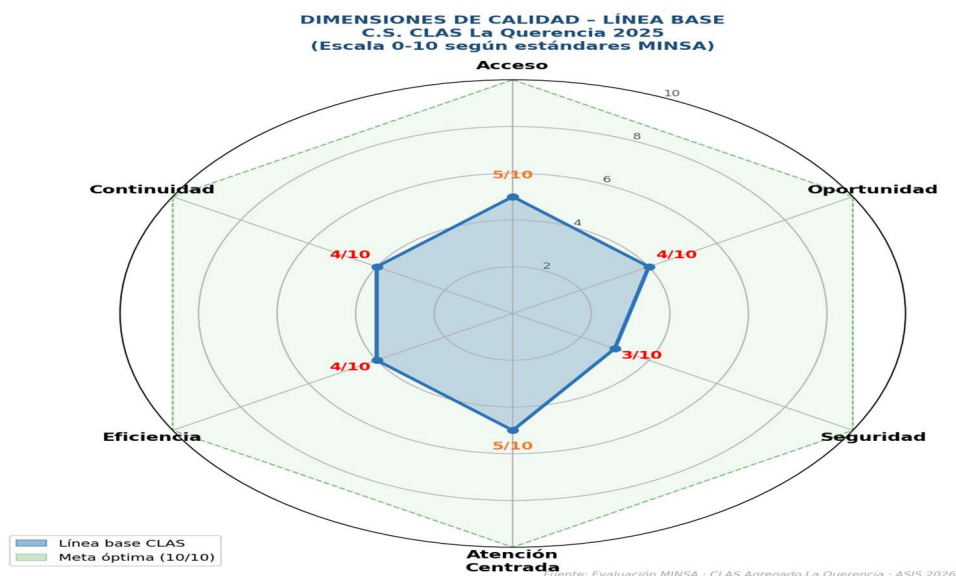


Figura 15. Radar de calidad asistencial – línea base 2025 vs meta óptima MINSA (escala 0-10)

El análisis de las 6 dimensiones de calidad muestra un desempeño promedio de 4.2/10. Las dimensiones de Acceso y Atención Centrada alcanzan 5/10, mientras Seguridad (3/10) es la brecha más crítica, asociada a la falta de agua segura en 4 de 5 EEES y ausencia de protocolos de seguridad del paciente.

Dimensión	Puntuación Actual	Meta 2028	Brecha	Acción prioritaria
Acceso	5/10	10/10	5 pts	Horarios extendidos, movilidad rural
Oportunidad	4/10	10/10	6 pts	Reducir espera a ≤45 min
Seguridad	3/10	10/10	7 pts	Agua segura, protocolos EAE
Atención Centrada	5/10	10/10	5 pts	Satisfacción usuaria, IAMC
Eficiencia	4/10	10/10	6 pts	Digitalización, HCE
Continuidad	4/10	10/10	6 pts	Referencia/contrarreferencia

4.3 Financiamiento por Tipo de Asegurado – 2025

Financiador	N° Atenciones	% del Total	Observación
SIS	44,812	70.1%	Principal financiador público
OTROS	18,148	28.4%	Requiere análisis de subregistro
Usuario (Pago directo)	961	1.5%	RDR – recursos directamente recaudados
EsSalud (Convenio)	19	0.03%	Convenio mínimo
Exonerado	3	0.00%	Exonerado de pago
TOTAL	63,943	100%	

El 70.1% de las atenciones es financiado por el SIS, evidenciando alta dependencia de transferencias públicas. El pago directo (1.5%) limita los recursos propios. La eficiencia en codificación y presentación de prestaciones SIS es clave para la sostenibilidad financiera.

5. CAPACIDAD INSTALADA: RECURSOS HUMANOS, INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN INSTITUCIONAL

Esta sección complementa el análisis epidemiológico y de gestión (Capítulos 3 y 4) con la información institucional del Formulario N° 3 – Informe de Situación Institucional 2025, el Cuadro de Personal Existente y Brechas 2026, y los planos de infraestructura del establecimiento sede, a fin de sustentar técnicamente las brechas de oferta de servicios del CLAS Agregado La Querencia.

5.1 Red de Establecimientos y Categorización

El CLAS Agregado La Querencia gestiona una red de cinco (05) establecimientos de salud operativos durante la totalidad del ejercicio 2025, sin cierres ni suspensiones reportadas, que atienden una población asignada (INEI/RIS) de 28,331 habitantes:

N°	Establecimiento	Categoría	Código IPRESS	Horario	Población Asignada (INEI)
1	C.S. CLAS A. La Querencia (Sede)	I-3	000005826	08:00–20:00 h L-S	22,494 hab.
2	P.S. Túpac Amaru	I-2	000005827	08:00–14:00 h L-S	1,775 hab.
3	P.S. Cabuyal	I-2	000005828	14:00–20:00 h L-S	1,196 hab.
4	P.S. Huerta Margaret	I-2	000005829	08:00–14:00 h L-S	1,023 hab.
5	P.S. Centenario (Huacho Chico)	I-2	000005830	14:00–20:00 h L-S	1,843 hab.
	TOTAL RED				28,331 hab.

El C.S. La Querencia (Sede, categoría I-3) concentra el 79.4% de la población asignada de la red y opera como Puerta de Entrada (12 horas) y punto de referencia de los cuatro puestos de salud periféricos. La población asignada a la sede creció 279.6% entre 2019 (8,046 hab.) y 2025 (22,494 hab.), presionando significativamente su capacidad resolutive como establecimiento I-3.

5.2 Dotación de Recursos Humanos y Brecha 2026

El Cuadro de Personal Existente y Brechas 2026 (elaborado por la gestión institucional) consolida la dotación de recursos humanos —nombrado, CAS y por terceros/locación de servicios— de los cinco establecimientos de la red, e identifica una brecha total de 25 plazas asistenciales y administrativas por cubrir:

Nº	Profesión	Nombrado	CAS	Tercero	Existente (red)	Brecha (red)
1	Psicología	1	0	0	1	3
2	Obstetriz	7	3	1	11	3
3	Téc. Enfermería	25	0	1	26	3
4	Médico	5	2	0	7	2
5	Odontología	4	0	0	4	2
6	Nutrición	1	1	0	2	2
7	Trabajadora Social	0	2	0	2	2
8	Enfermera	7	7	0	14	1
9	Téc. Laboratorio	1	2	0	3	1
10	Téc. Farmacia	1	0	2	3	1
11	Téc. Adm. (Estadística)	0	1	1	2	1
12	Mantenimiento	0	0	0	0	1
13	Limpieza	0	0	1	1	1
14	Vigilante	0	0	1	1	1
15	Chofer	1	2	0	3	1
16	Administrador	1	0	0	1	0
17	Personal Adm. (SIS)	0	0	3	3	0
	TOTAL				84	25

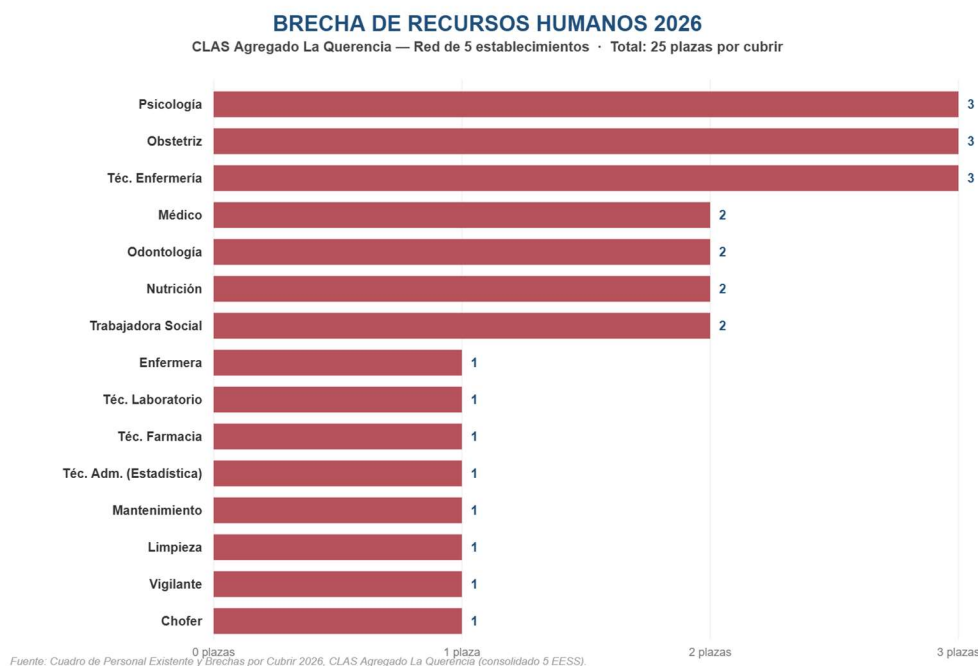


Figura 16. Brecha de recursos humanos por profesión, red CLAS Agregado La Querencia 2026 (Fuente: Cuadro de Personal Existente y Brechas 2026)

⚠ Las mayores brechas se concentran en Psicología, Obstetriz y Técnicos de Enfermería (3 plazas cada una). El déficit de Psicología (1 nombrado para toda la clas) es consistente con el hallazgo de la Sección 3.9 (ratio 1:55,000 hab. frente al estándar OMS de 1:10,000). Los puestos de salud periféricos (Túpac Amaru, Cabuyal, Huerta Margaret y Centenario) concentran la mayor proporción de brecha relativa: cada uno opera con apenas 1 profesional nombrado por especialidad y sin personal administrativo, de mantenimiento, limpieza ni vigilancia asignado establemente.

Entre octubre y diciembre de 2025 la gestión institucional logró revertir parcialmente el déficit histórico en el establecimiento sede: recuperación de una plaza nombrada de Enfermería, cobertura de una plaza CAS de Enfermería, asignación de una Nutricionista nombrada y la incorporación de una técnica de Enfermería y un técnico administrativo para digitación HIS/estadística. La brecha en los puestos periféricos se mantiene pendiente.

Como referencia complementaria, el sustento técnico GEORIS (28/10/2025) para la recategorización a I-4 estima una brecha de personal profesional y técnico de 33 plazas para la sede proyectada como nodo de referencia de la microrred, cifra no directamente comparable con las 25 plazas del cuadro anterior por diferir en método y alcance (dotación actual vs. dotación óptima proyectada para un establecimiento I-4).

5.3 Infraestructura Física y Proyecto de Recategorización a I-4

El establecimiento sede opera en una edificación de dos niveles (área construida aprox. 18.48 m × 12.67 m por planta) con los siguientes ambientes: Medicina General I y II, Obstetricia, Psicología, Nutrición, Toma de Muestra, Servicio de TBC, Servicio de SIS, Sala de Espera (2), Hall y Servicios Higiénicos diferenciados por sexo en cada nivel. Se encuentra en ejecución la obra de ampliación “Construcción de Sala de Procedimientos Ambulatorios” (R.G. N° 461-2024-MPH-GDUR, CUI 2621770), por S/ 499,927.77, con plazo de 75 días calendario, iniciada en octubre de 2025.

El diagnóstico institucional identifica las siguientes limitaciones estructurales del establecimiento I-3 actual: sala de partos no operativa 24/7, ausencia de capacidad de estabilización para emergencias, laboratorio básico con cartera de pruebas limitada, carencia

de sala de procedimientos y observación diferenciadas, número insuficiente de consultorios, y ausencia de ambientes diferenciados para TBC/ETS.

⚠ El CLAS cuenta con Opinión Técnica Favorable para la construcción de un nuevo Centro de Salud categoría I-4, sustentada en datos GEORIS (21,142–27,317 hab. según ámbito, 5,445 familias, 5 sectores) y en un terreno donado ya inscrito y saneado (Partida Electrónica N° 60177393 SUNARP-Huaral, 2,461.13 m², titular Gobierno Regional de Lima–DIRESA), pendiente de verificación de linderos por la Procuraduría Pública Regional. La recategorización permitiría resolver entre 70% y 80% de la demanda del ámbito sin derivaciones al Hospital Huaral.

5.4 Situación Institucional y Financiera

El modelo de cogestión (Ley N° 29124, D.S. N° 017-2008-SA) mantiene gobernanza activa: Consejo Directivo registrado en SUNARP (mandato 2024-2026, con Consejo 2026-2028 en trámite de inscripción) y Gerencia CLAS designada por concurso público, vigente hasta enero de 2027. No obstante, el convenio de cogestión tripartito (DIRESA–Municipalidad–CLAS) no se encuentra vigente al cierre de 2025, constituyendo una brecha normativa en regularización mediante la conclusión del Plan de Salud Local (PSL).

Indicador Financiero 2025	Valor
Ingreso total institucional (RDR + SIS)	S/ 174,393.63
Resultado económico del ejercicio	+S/ 4,776.89 (superavitario)
Deuda acumulada al 31/12/2025	S/ 39,505.80 (22.65% del ingreso)
Producción HIS 2025 (red completa, 5 EESS)	91,284 atenciones · 18,971 pacientes únicos
Atenciones financiadas por SIS (red)	62,786 (68.8%)

La producción HIS 2025 de la red completa (91,284 atenciones, 18,971 pacientes únicos) es superior a la cifra de 63,943 atenciones reportada en la Sección 4.1, dado que esta última corresponde únicamente al C.S. sede; la cifra de red incorpora los cuatro puestos periféricos. El SIS financia el 68.8% de las atenciones de la red, y la situación financiera institucional es estable, con resultado económico positivo y endeudamiento moderado (22.65% del ingreso anual), aunque persiste una alta concentración de ingresos propios (87.3%) en el establecimiento sede.

Estos hallazgos —brecha de recursos humanos, limitaciones de infraestructura y situación institucional— deben incorporarse a la matriz de brechas estratégicas y al plan de acción 2025-2028 (Capítulo 6) en la próxima actualización del ASIS.

6. BRECHAS ESTRATÉGICAS Y PLAN DE ACCIÓN 2025-2028

6.1 Brechas Estratégicas Priorizadas

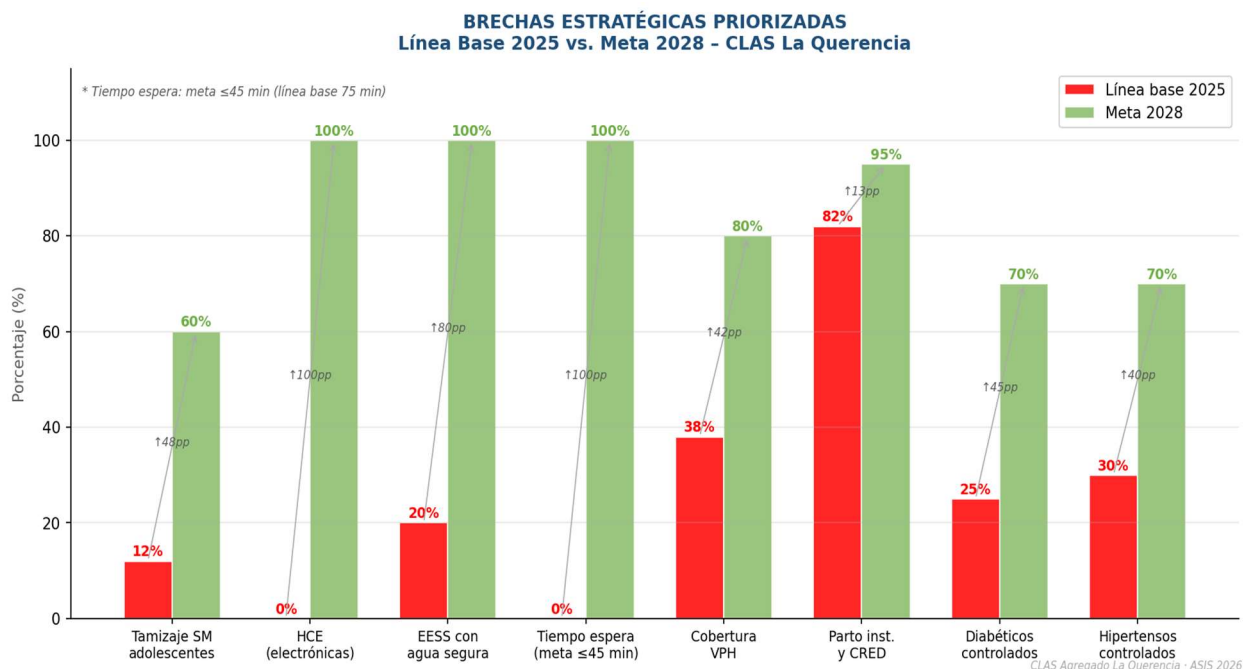


Figura 17. Brechas estratégicas: línea base 2025 vs meta 2028 – CLAS La Querencia

N°	Brecha	Línea Base	Meta 2028	Prioridad
1	Tamizaje salud mental adolescentes	12%	60%	ALTA
2	Historias clínicas electrónicas	0%	100%	ALTA
3	EESS con agua segura	20%	100%	ALTA
4	Tiempo de espera consulta externa	75 min	≤45 min	ALTA
5	Cobertura VPH adolescentes	38%	80%	ALTA
6	Parto institucional y CRED	82%	95%	MEDIA
7	Diabéticos controlados	25%	70%	ALTA
8	Hipertensos controlados	30%	70%	ALTA
9	Agentes comunitarios activos	2/6 sectores	6/6 sectores	MEDIA
10	Recaudación propia (% del total)	1.5%	8%	MEDIA

7. Recomendaciones Estratégicas 2025-2028

Basado en el análisis epidemiológico y de gestión, se priorizan las siguientes líneas de acción:

Eje	Recomendación	Plazo
Adolescentes	Consultorio amigable, tamizaje SM universal, VPH casa por casa, consejería SSR en colegios	2025
Digitalización	Capacitar 100% personal en SIHCE; 50% HCE digitalizadas en 2026; 100% en 2027	2025-2027
Agua segura	Tanques + cloradores en todos los EEES; convenio con municipalidad y OTASS	2025-2026
Calidad	Comité de calidad, monitoreo mensual, encuesta de satisfacción semestral	2025
Salud mental	Ampliar a 4 psicólogos; tamizaje PHQ-9/GAD-7 universal	2026
Nutrición	Programa de actividad física comunitaria; consejería nutricional estructurada por etapa	2025
RR.HH.	Pausas activas, consejería al personal, programa de reconocimiento, protocolo anti-violencia	2025
Finanzas	Yape + depósitos diarios; plan de negocios para laboratorio; salud ocupacional como nuevo servicio	2025-2026
Acceso rural	Horarios extendidos hasta 8 pm; ambulancia comunitaria rotativa para sectores 31 y 30	2026
Participación	Comités de salud en cada sector; 2 agentes comunitarios por sector; rendición de cuentas bimensual	2025

8. Conclusiones del ASIS

8.1 Perfil epidemiológico: una doble carga que se agrava en cascada

El CLAS Agregado La Querencia enfrenta una doble carga epidemiológica claramente documentada en el Capítulo 3: enfermedades transmisibles aún dominantes (IRA con 5,432 casos distritales y 2,923 en el propio establecimiento, EDA con 4,210 casos y un patrón estacional inverso a las IRA, y tuberculosis con una tasa de 26.4 x 100,000 que supera el umbral de control) conviven con un incremento acelerado de enfermedades crónicas no transmisibles. El hallazgo más crítico es nutricional: 61.3% de los adultos evaluados presenta exceso de peso (31.2% sobrepeso + 30.1% obesidad), con una brecha de género relevante (34.3% de obesidad en mujeres frente a 18.7% en hombres). Este patrón no es exclusivo de la adultez: en adolescentes de 12-17 años, el desequilibrio nutricional, sobrepeso y obesidad concentran más del 44% de las atenciones del grupo (Sección 3.5), lo que anticipa que la actual prevalencia adulta de ECNT seguirá creciendo si no se interviene en esta cohorte. La subregistración de HTA (13 casos) y DM (25 casos) frente a estimaciones reales de 18% y 12% de la población adulta (Sección 3.8) indica que el sistema de vigilancia detecta hoy solo una fracción de la carga real: el tamizaje activo, no solo la atención de demanda, debe convertirse en la puerta de entrada al control de crónicos.

La salud mental es la brecha más silenciada del perfil epidemiológico: 657 diagnósticos registrados (Sección 3.9) frente a una estimación de más de 1,600 casos reales, sostenida por un ratio de 1 psicólogo por 55,000 habitantes —5.5 veces peor que el estándar OMS de 1:10,000—. Esta misma insuficiencia de oferta explica por qué el tamizaje de salud mental en adolescentes alcanza apenas 12% (frente a una meta de 60%, Sección 6.1) y por qué la mortalidad por suicidio y trastornos mentales (72 defunciones distritales,

Sección 3.3) se mantiene como una de las cuatro causas principales. La anemia, con 38.7% de prevalencia en adultas jóvenes de 18-29 años (Sección 3.7), añade una tercera línea de atención materno-reproductiva que compite por los mismos recursos humanos escasos.

8.2 Gestión y calidad: la oferta no está dimensionada para la demanda que documenta el perfil epidemiológico

El Capítulo 4 muestra por qué estas brechas epidemiológicas no se cierran: el desempeño promedio de calidad asistencial es de solo 4.2/10, con Seguridad del paciente en 3/10 — la dimensión más crítica, asociada al 20% de EESS con agua segura (Sección 4.2)— y Oportunidad en 4/10, reflejada en 75 minutos de espera promedio frente a una meta de ≤45 minutos. La producción de 63,943 atenciones anuales en la sede (91,284 si se suma la red completa, Sección 5.4) está concentrada en enfermería, obstetricia y medicina general (72.2% del total), mientras psicología aporta solo 2.5% de la producción: la misma proporción marginal que explica el subregistro de salud mental documentado en 3.9. La dependencia del SIS como financiador (70.1% de las atenciones, Sección 4.3) deja un margen de maniobra financiera muy estrecho —el pago directo es apenas 1.5%— para invertir en las mejoras de calidad que la evaluación exige.

8.3 Capacidad institucional: la brecha de recursos humanos es la causa raíz común

El Capítulo 5 identifica el eslabón que conecta el perfil epidemiológico con el desempeño de gestión: una brecha de 25 plazas asistenciales y administrativas en la red (Sección 5.2), concentrada precisamente en Psicología, Obstetiz y Técnicos de Enfermería (3 plazas cada una). El déficit de 1 psicólogo nombrado para toda la red es la causa estructural directa del subregistro de salud mental de la Sección 3.9 y del bajo tamizaje adolescente de la Sección 6.1. Los cuatro puestos de salud periféricos (Túpac Amaru, Cabuyal, Huerta Margaret y Centenario) operan con apenas un profesional nombrado por especialidad, sin personal administrativo, de mantenimiento, limpieza ni vigilancia estable, lo que erosiona la capacidad resolutoria justo en los sectores de mayor riesgo sanitario (31, 17 Oeste y 17 Este, Sección 2.2). El establecimiento sede, cuya población asignada creció 279.6% entre 2019 y 2025 sin cambio de categoría, opera al límite de su capacidad como I-3: sin sala de partos 24/7, sin estabilización de emergencias y sin ambientes diferenciados para TBC. El proyecto de recategorización a I-4 —con terreno saneado y opinión técnica favorable— resolvería entre 70% y 80% de la demanda del ámbito sin derivaciones al Hospital Huaral, y es, en ese sentido, la intervención estructural individual con mayor potencial de impacto sobre todas las brechas descritas en los capítulos 3 y 4. La situación financiera, aunque superavitaria (+S/ 4,776.89) y con endeudamiento moderado (22.65% del ingreso), no genera hoy el excedente necesario para financiar por sí sola esa expansión de personal e infraestructura sin apoyo de DIRESA y la municipalidad.

8.4 Síntesis: diez brechas, una hoja de ruta hacia 2028

Las diez brechas estratégicas priorizadas en el Capítulo 6 son la traducción operativa de los hallazgos de los capítulos 2 a 5: siete de ellas tienen prioridad ALTA (tamizaje de salud mental adolescente, historias clínicas electrónicas, agua segura, tiempo de espera, cobertura VPH, control de diabéticos e hipertensos) porque atacan directamente las causas raíz —insuficiencia de personal especializado, infraestructura no categorizada, digitalización nula— identificadas en las secciones 4.2 y 5.2. Las recomendaciones del Capítulo 7 (ampliar a 4 psicólogos, digitalizar el 100% de historias clínicas para 2027,

instalar agua segura en todos los EESS, y extender horarios en sectores rurales) están explícitamente calibradas contra esas mismas brechas, no como líneas de acción genéricas. La implementación conjunta de estas diez brechas tiene el potencial de reducir la carga de enfermedad prevenible en un 35-40% en el horizonte 2025-2028, mejorando la calidad de vida de los 110,000 habitantes del ámbito distrital y de los 28,331 habitantes con población asignada directa a la red del CLAS. El factor crítico de éxito, visible de manera transversal en los cinco capítulos analíticos, es uno solo: cerrar la brecha de 25 (o 33, en el escenario I-4) plazas de recursos humanos, sin la cual ninguna meta de calidad, cobertura o control de crónicos propuesta para 2028 resulta alcanzable con la dotación actual.